

Flashcards ENARM -- Medicina Interna

41 patologías · 225 tarjetas · generado 2026-09-12 por La Mole. Frente = pregunta tipo ENARM; Reverso = respuesta + dato diferencial.

Amiloidosis

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente de 70 años con síndrome nefrótico y cardiomiopatía restrictiva sin hipertrofia. ¿Qué tinción confirma el diagnóstico de amiloidosis?

REVERSO: Biopsia con tinción de rojo Congo que muestra birrefringencia verde manzana. Diferencial: las demás nefropatías y cardiomiopatías restrictivas no muestran depósito amiloide.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué tipo de amiloidosis se asocia a mieloma múltiple y qué proteína precursora la forma?

REVERSO: La amiloidosis AL (primaria), por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Diferencial: la AA (secundaria) deriva de la proteína SAA en inflamación crónica (tuberculosis, artritis reumatoide).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente en diálisis prolongada con depósitos amiloides. ¿Qué proteína precursora es responsable?

REVERSO: β 2-microglobulina (amiloidosis relacionada con diálisis). Diferencial: la forma ATTR (transtiretina) cursa como variedad senil en ancianos y hereditaria (variante Val30Met).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos electrocardiográficos y ecocardiográficos sugieren afectación cardíaca amiloide?

REVERSO: ECG con baja amplitud, ondas Q anormales e inversión de T; ecocardiograma con ventrículo izquierdo normal y dilatación auricular bilateral. Diferencial: otras cardiomiopatías restrictivas cursan con hipertrofia evidente.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la amiloidosis AL y de la forma ATTR?

REVERSO: AL: quimioterapia con bortezomib, melfalán y dexametasona, y trasplante autólogo de médula ósea. ATTR: tafamidis; trasplante hepático en formas hereditarias. Diferencial: la AA se trata controlando la enfermedad inflamatoria subyacente.

Anemia Aplásica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con pancitopenia. ¿Qué estudio establece el diagnóstico definitivo de anemia aplásica?

REVERSO: Biopsia de médula ósea que demuestre hipocelularidad. Diferencial: el síndrome mielodisplásico cursa con anormalidad cromosómica; antes de la biopsia deben descartarse deficiencias de hierro, B12 y folato.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de elección de la anemia aplásica y qué se emplea si el paciente no es candidato?

REVERSO: Trasplante alogénico de médula ósea (recuperación completa en más de 80% con donador compatible). Si no es candidato (edad o falta de donador): tratamiento inmunosupresor con globulina antitimocito con o sin ciclosporina. Diferencial: la respuesta a inmunosupresores es de 60-80% según la GPC.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Neonato con aplasia radial, aplasia de pulgares y malformaciones renales. ¿Diagnóstico y herencia?

REVERSO: Anemia de Fanconi, de herencia autosómica recesiva. Diferencial: el síndrome de Shwachman-Diamond cursa con insuficiencia pancreática en niños.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el motivo de consulta más frecuente en la anemia aplásica?

REVERSO: El sangrado anormal (petequias, equimosis, epistaxis, menorragia), acompañado de palidez y fiebre. Diferencial: la pancitopenia es el dato clave frente a la anemia megaloblástica aislada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la mortalidad a un año sin tratamiento y qué complicaciones clonales tardías puede desarrollar la anemia aplásica?

REVERSO: Sin tratamiento la mortalidad a un año es de 80-90% (67% en los primeros 6 meses, por infección o sangrado); puede desarrollar hemoglobinuria paroxística nocturna, mielodisplasia o leucemia mielocítica aguda. Diferencial: la trombocitopenia persistente es el problema a largo plazo más común.

Anemia Hemolítica Autoinmune

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anemia hemolítica con Coombs directo positivo y esferocitos en frotis. ¿Qué tipo de anemia hemolítica autoinmune es y cuál es su mecanismo?

REVERSO: Enfermedad caliente (50-70%): anticuerpos IgG con o sin complemento (C3d); los eritrocitos opsonizados son secuestrados en el bazo. Diferencial: la enfermedad fría es mediada por IgM más C3d, con agregados eritrocitarios y acrocianosis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la prueba que confirma el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune?

REVERSO: La prueba de antiglobulina (Coombs) directa, que detecta autoanticuerpos unidos a la membrana eritrocitaria. Diferencial: una minoría de casos presenta resultado falsamente negativo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes?

REVERSO: Corticoides (prednisona o metilprednisolona, según la GPC); si hay refractariedad o corticodependencia, esplenectomía. Diferencial: en la enfermedad por aglutininas frías los corticoides suelen no ser útiles; el manejo es evitar el frío e investigar linfoma de células B.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Adulto mayor de 50 años con coluria, ictericia y acrocianosis de manos, pies y lóbulos auriculares. ¿Qué anemia hemolítica debe sospecharse?

REVERSO: Enfermedad crónica por aglutininas frías: IgM más C3d (siempre), con agregados eritrocitarios en el frotis. Diferencial: los anticuerpos calientes producen esferocitos y responden a esteroides; la hemoglobinuria fría paroxística se presenta en niños y adultos jóvenes.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué autoanticuerpos definen la hemoglobinuria fría paroxística y en qué población es frecuente?

REVERSO: Los anticuerpos de Donath-Landsteiner (IgG), inducidos por el frío, en niños y adultos jóvenes, con frecuencia postvirales o asociados a sífilis. Diferencial: la Coombs directa detecta IgG y complemento, pero la indirecta es negativa; cuadro agudo, severo y autolimitado.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué situación constituye una emergencia médica en la anemia hemolítica autoinmune que exige tratamiento transfusional?

REVERSO: Hemoglobina menor de 4 g/dl, edema pulmonar o amenaza a la función cardíaca o cerebral. Diferencial: si tras esplenectomía persiste hemólisis con hemoglobina menor de 10 g/dl, puede optarse por rituximab, ciclofosfamida, azatioprina o micofenolato.

Anemia Hemolítica

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuáles son los hallazgos de laboratorio que definen la anemia hemolítica?

REVERSO: Elevación de bilirrubina no conjugada, deshidrogenasa láctica y conteo reticulocitario, con haptoglobina indetectable. Diferencial: en la hemorragia aguda no existe elevación de bilirrubina indirecta ni reticulocitosis comparable.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Frotis con esquistocitos, hemoglobinuria y haptoglobina descendida. ¿Hemolisis extra o intravascular y qué entidades?

REVERSO: Intravascular: hemoglobinuria paroxística nocturna y fría, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico y coagulación intravascular diseminada. Diferencial: la extravascular muestra esferocitos y destrucción por el sistema reticuloendotelial en bazo e hígado.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué prueba identifica la hemolisis de causa inmune y qué categorías etiológicas existen?

REVERSO: Prueba de Coombs directa positiva (anticuerpos IgG). Causas adquiridas: inmunes, traumáticas (micro y macroangiopáticas), membranales, infecciosas y daño osmótico. Diferencial: las microangiopáticas (PTT, SHU, síndrome de HELLP, CID) tienen Coombs negativo con esquistocitos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Paciente portadora de válvula cardíaca protésica con anemia hemolítica. ¿A qué categoría etiológica pertenece?

REVERSO: Hemolisis traumática macroangiopática. Diferencial: dentro de las traumáticas microangiopáticas se incluyen PTT, SHU, síndrome de HELLP, CID, vasculitis, eclampsia e hipertensión maligna.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Frotis con esferocitos y Coombs positivo. ¿Dónde ocurre la destrucción eritrocitaria?

REVERSO: Hemolisis extravascular: los eritrocitos opsonizados por IgG son fagocitados por el sistema reticuloendotelial del hígado y el bazo. Diferencial: en la intravascular el eritrocito se destruye en la luz vascular con hemoglobinuria y esquistocitos.

Anemia Megaloblástica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anemia con VCM mayor de 100 fL y neutrófilos hipersegmentados. ¿Diagnóstico y qué series hematopoyéticas afecta?

REVERSO: Anemia megaloblástica; afecta las tres series y puede manifestarse como pancitopenia. Diferencial: la macrocitosis no megaloblástica (hepatopatía, hipotiroidismo) cursa con neutrófilos y plaquetas morfológicamente normales.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la causa más común de anemia megaloblástica y cuál es la causa más frecuente de esa deficiencia?

REVERSO: La deficiencia de vitamina B12; su causa más frecuente es la anemia perniciosa, por destrucción autoinmune de las células parietales gástricas. Diferencial: el déficit de folato proviene de alcoholismo, malabsorción o mayor requerimiento (embarazo, diálisis, hemólisis).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué metabolito sérico elevado es específico de la deficiencia de vitamina B12?

REVERSO: El ácido metilmalónico, porque la B12 es cofactor esencial de la conversión de metilmalonil-CoA a succinil-CoA. Diferencial: la homocisteína se eleva en ambos déficits; su aumento aislado sugiere deficiencia de ácido fólico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la prueba de elección para el diagnóstico de anemia perniciosa?

REVERSO: La detección de autoanticuerpos contra el factor intrínseco. Diferencial: la B12 se absorbe en el íleon terminal; intestino corto, asa ciega y parasitosis también la producen.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el esquema de tratamiento parenteral de la deficiencia de vitamina B12 y el del folato?

REVERSO: Vitamina B12: 1000 µg/día por 1-2 semanas, luego 1000 µg/semana por 4 semanas y mantenimiento de 100 o 1000 µg intramuscular de por vida. Folato: 1 mg/día oral. Diferencial: tratar la deficiencia de B12 con folato corrige la anemia pero puede acelerar las anormalidades neurológicas.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué manifestación clínica distingue a la deficiencia de vitamina B12 de la de folato, y qué complicación puede tener el tratamiento?

REVERSO: El compromiso neurológico (parestesias, degeneración medular combinada subaguda, demencia), que puede preceder a la anemia; el tratamiento puede complicarse con hipocalcemia durante la primera semana. Diferencial: la carencia de folato cursa con glositis, esplenomegalia y hepatomegalia, sin afectación neurológica.

Anemia Sideroblástica

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el hallazgo en el aspirado medular que confirma el diagnóstico de anemia sideroblástica?

REVERSO: Sideroblastos en anillo: almacenamiento de hierro (fosfato e hidróxido férricos) en las mitocondrias de los normoblastos. Diferencial: en la ferropenia el hierro medular está ausente en la tinción de azul de Prusia.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Frotis con células dimórficas grandes y pequeñas con cuerpos de Pappenheimer. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Anemia sideroblástica (siderocitos en tinciones para hierro, azul de Prusia). Diferencial: la talasemia cursa con microcitosis difusa sin siderocitos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué perfil de hierro presenta la anemia sideroblástica?

REVERSO: Hierro sérico y ferritina elevados, con transferrina disminuida y porcentaje de saturación aumentado. Diferencial: la ferropenia cursa con hierro y ferritina bajos; la anemia de enfermedad crónica con ferritina normal o alta pero saturación baja.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué tratamiento es eficaz en las formas hereditarias y en las causadas por isoniazida, pirazinamida o cicloserina?

REVERSO: Dosis altas de vitamina B6 (piridoxina). Diferencial: las formas reversibles (etanol, cloranfenicol, deficiencia de cobre) mejoran retirando el agente causante.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué riesgo hematológico presenta la anemia sideroblástica refractaria asociada a síndromes mielodisplásicos?

REVERSO: Evolución a leucemia en aproximadamente 5% de los casos. Diferencial: las formas hereditarias cursan como anemia microcítica hipocrómica; las adquiridas pueden ser normocíticas o macrocíticas.

Anemia de Enfermedad Crónica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Anemia en paciente con artritis reumatoide: hierro sérico bajo, ferritina normal o elevada y saturación de transferrina baja. ¿Diagnóstico?

REVERSO: Anemia de enfermedad crónica (microcítica o normocítica con ferritina normal o elevada). Diferencial: la ferropenia cursa con ferritina baja (menor de 12 ng/ml); si coexisten ambas, el diagnóstico se dificulta.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué hormona explica la indisponibilidad del hierro en la anemia de enfermedad crónica y cómo se induce?

REVERSO: La hepcidina, inducible por IL-1 e IL-6, disminuye la absorción de hierro en el intestino delgado e inhibe su liberación desde los macrófagos. Diferencial: el hierro está abundante en el sistema reticuloendotelial pero indisponible para los precursores eritroides.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento que produce mejoría clínica definitiva en la anemia de enfermedad crónica?

REVERSO: El tratamiento de la enfermedad subyacente; los agentes eritropoyéticos (epoyetina- α , darbepoyetina- α) solo reducen los requerimientos transfusionales. Diferencial: si no hay respuesta adecuada a eritropoyetina, debe excluirse la deficiencia de hierro.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué enfermedades no inflamatorias cursan con anemia de patrón de enfermedad crónica?

REVERSO: Insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hepatopatía alcohólica y enfermedad renal crónica. Diferencial: incluso en diabéticos sin insuficiencia renal la respuesta de la eritropoyetina a la anemia se encuentra truncada.

Anemia por Deficiencia de Hierro

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de laboratorio más sensible y específico para evaluar reservas de hierro y a partir de qué cifra es diagnóstico?

REVERSO: La ferritina; valores menores de 12 ng/ml son virtualmente diagnósticos. Diferencial: la tinción de azul de Prusia del aspirado medular es el estándar de oro, pero no se realiza de rutina por ser dolorosa y costosa.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Varón de 60 años con anemia microcítica (VCM menor de 80 fL) e hipocromía. ¿Qué estudio es obligatorio y por qué?

REVERSO: Detección de sangre en heces: en la mayoría de los pacientes con anemia ferropriva debe asumirse pérdida sanguínea gastrointestinal. Diferencial: en la mujer en edad fértil la causa habitual es el sangrado menstrual.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el fármaco y la dosis oral de primera línea para la reposición de hierro en el adulto?

REVERSO: Sulfato ferroso (primera elección): 180 mg/día de hierro elemental, dividido en 3 dosis. Diferencial: en niños la dosis es de 3-6 mg/kg/día dividida en 1-3 dosis.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuáles son las manifestaciones propias de la ferropenia?

REVERSO: Pica (particularmente pagofagia), glositis, queilitis angular, coiloniquia, disfagia, ardor lingual y síndrome de piernas inquietas. Diferencial: la anemia de enfermedad crónica no cursa con estos estigmas epiteliales.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la reposición parenteral de hierro?

REVERSO: Intolerancia grave al tratamiento oral, trastorno gastrointestinal que contraindique la vía oral o previsión de que el tratamiento oral será insuficiente, bajo indicación del hematólogo. Diferencial: la transfusión de paquetes globulares se reserva para descompensación hemodinámica, insuficiencia respiratoria o cirugía urgente.

Asma

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se confirma el diagnóstico de asma con la espirometría en mayores de 5 años?

REVERSO: Obstrucción con relación VEF1/CVF menor de 0.7 en adultos (menor de 0.8 en niños) y reversibilidad con aumento del VEF1 mayor de 12% y más de 200 ml tras salbutamol. Diferencial: en menores de 5 años se emplea prueba terapéutica con corticosteroides inhalados durante al menos 2 semanas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el manejo preferido de los pasos 1 y 2 en pacientes de 12 años o mayores?

REVERSO: Paso 1: rescate con corticosteroide inhalado a dosis baja más formoterol en el mismo inhalador. Paso 2: corticosteroide inhalado a dosis baja como controlador diario. Diferencial: el montelukast es alternativa (especialmente con rinitis alérgica) con advertencia de efectos adversos neuropsiquiátricos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué fármacos biológicos están indicados en el asma grave tipo 2 y a qué se dirigen?

REVERSO: Omalizumab (anti-IgE libre, asma alérgica con IgE sérica 30-1500 UI/ml), mepolizumab (anti-IL-5, 100 mg subcutáneos cada 4 semanas), reslizumab, benralizumab y dupilumab (anti-receptor de IL-4). Diferencial: requieren fenotipo alérgico o eosinofílico y fracaso de corticosteroide inhalado a dosis alta más β_2 de acción prolongada.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la piedra angular del tratamiento de la exacerbación del asma y qué se añade si no hay respuesta?

REVERSO: Salbutamol (agonista β_2 de acción corta); si no responde se añade ipratropio, con corticoides sistémicos tempranos y oxígeno a flujo controlado (2-4 l/min). Diferencial: ante persistencia del broncoespasmo en adultos puede emplearse sulfato de magnesio.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos definen una exacerbación asmática de riesgo vital?

REVERSO: Habla ausente, bradipnea o apnea, FC mayor de 120 con bradicardia o parada, movimiento paradójico o ausente de la musculatura accesorio, silencio auscultatorio y nivel de alerta disminuido o coma. Diferencial: una PaCO₂ mayor de 45 mmHg indica falla respiratoria hipercápnica con riesgo vital.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué define al asma grave?

REVERSO: La que requiere corticosteroide inhalado a dosis alta más un segundo controlador o corticosteroides sistémicos para evitar el descontrol, o que persiste descontrolada incluso con ello (paso 5). Diferencial: la inflamación no tipo 2 (neutrófila, IL-17) responde pobremente a esteroides.

Carcinoma Hepatocelular

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el marcador tumoral del carcinoma hepatocelular y cuál es la estrategia de tamizaje?

REVERSO: La alfa-fetoproteína (útil en diagnóstico y seguimiento); tamizaje con ultrasonido y determinación de alfa-fetoproteína al menos de forma anual en pacientes con factores de riesgo. Diferencial: la sensibilidad de la tomografía simple es solo de 56%, por tumores pequeños isodensos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuáles son los principales factores de riesgo del carcinoma hepatocelular?

REVERSO: Cirrosis hepática, infección crónica por virus de la hepatitis B o C, hemocromatosis hereditaria y alcoholismo; también torotrasto, cloruro de vinilo, esteroides anabólicos, arsénico y aflatoxinas. Diferencial: predomina en varones, con incidencia máxima entre la quinta y sexta décadas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué alteraciones de laboratorio y síndromes paraneoplásicos caracterizan al carcinoma hepatocelular?

REVERSO: Policitemia (3-12%), hipercalcemia, hipoglucemia, hipercolesterolemia (10-40%), porfiria cutánea tardía y disfibrinogenemia. Diferencial: la diarrea crónica es una presentación rara (1% de los casos).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la resección quirúrgica del carcinoma hepatocelular?

REVERSO: Con menos de 3 nódulos de diámetro menor de 3 cm y función hepática adecuada; solo 15-30% de los pacientes son candidatos, con supervivencia a 5 años de 30%. Diferencial: en enfermedad no resecable se emplean medidas paliativas (quimioembolización, ablación ética percutánea o ablación por radiofrecuencia).

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el sitio de metástasis a distancia más frecuente del carcinoma hepatocelular?

REVERSO: El hueso; las metástasis distantes son infrecuentes incluso en enfermedad avanzada. Diferencial: la presentación aguda por necrosis central o hemorragia intraperitoneal ocurre en menos de 1% de los casos.

Cardiopatía Isquémica Crónica (Angina Estable)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica la angina de pecho?

REVERSO: Por la clínica: molestia subesternal o precordial de 15 segundos a 15 minutos, desencadenada por ejercicio, estrés, frío, coito o comida abundante, sin necrosis. Diferencial: el ECG en reposo puede ser normal incluso con coronariopatía anatómicamente extensa.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la terapia farmacológica inicial de la angina estable y con qué se alivia el episodio agudo?

REVERSO: Bloqueadores β como terapia inicial en ausencia de contraindicaciones; el alivio inmediato corresponde a nitroglicerina sublingual. Diferencial: si los bloqueadores β están contraindicados o no tolerados, se usan antagonistas de calcio o nitratos de acción prolongada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué fármacos conforman la prevención secundaria obligatoria en la cardiopatía isquémica crónica?

REVERSO: Ácido acetilsalicílico y estatina de alta intensidad en todos los pacientes. Diferencial: el IECA o ARA II se añaden con diabetes, disfunción ventricular sistólica o enfermedad renal crónica, y el inhibidor de SGLT2 si hay insuficiencia cardíaca.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué fármacos benefician al paciente con isquemia mediada por vasoconstricción coronaria?

REVERSO: Nitratos y antagonistas dihidropiridínicos de los canales de calcio (angina vasoespástica de Prinzmetal, en reposo o nocturna). Diferencial: cuando predomina el aumento de demanda, benefician los bloqueadores β y los no dihidropiridínicos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente durante un episodio anginoso?

REVERSO: Agudización y simetrización de la onda T, que significa isquemia subendocárdica; el ECG se vuelve anormal en 50% o más de los casos con trazo normal en reposo. Diferencial: la angina en reposo o nocturna anuncia cambio de patrón estable a inestable.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es la complicación principal de la cardiopatía isquémica estable?

REVERSO: La ruptura de la placa ateromatosa con progresión a síndrome coronario agudo (con o sin elevación del ST), falla cardíaca y complicaciones arrítmicas. Diferencial: la angiografía coronaria invasiva continúa siendo el estándar de oro de la definición anatómica.

Cáncer Tiroideo

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos ultrasonográficos sugieren malignidad en un nódulo tiroideo?

REVERSO: Microcalcificaciones, hipoecogenicidad, bordes irregulares, pérdida del halo de seguridad, hipervascularidad intranodal y linfadenopatía regional sospechosa. Diferencial: solo 5-10% de los nódulos tiroideos son malignos.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué carcinoma tiroideo metastatiza a ganglios cervicales y cuál a pulmón y hueso por vía hematógena?

REVERSO: El papilar metastatiza a ganglios linfáticos cervicales con crecimiento lento. El folicular y el de células de Hürtle, con invasión vascular, se asocian a metástasis a distancia en pulmones y esqueleto. Diferencial: el carcinoma de células de Hürtle no retiene la capacidad concentradora de yodo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué marcadores se emplean en el seguimiento del carcinoma medular de tiroides y por qué el yodo radiactivo es ineficaz?

REVERSO: Calcitonina y antígeno carcinoembrionario, porque surge de las células C parafoliculares, que no concentran yodo. Diferencial: se asocia a síndromes MEN 2a y 2b por mutación del protooncogén RET (autosómico dominante); la hipercalcitoninemia causa diarrea, prurito y bochornos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Masa cervical de crecimiento rápido y dolorosa en un adulto mayor. ¿Diagnóstico probable, pronóstico y tratamiento?

REVERSO: Carcinoma anaplásico: sobrevida media de 3-7 meses; la terapia convencional (radioterapia externa con doxorrubicina con o sin cisplatino) responde en 25% y la cirugía solo asegura la vía aérea. Diferencial: el linfoma tiroideo (bocio de crecimiento rápido y doloroso con tiroiditis autoinmune previa) responde a radioterapia y quimioterapia.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento fundamental de los carcinomas tiroideos diferenciados y cuándo se indica tiroidectomía total?

REVERSO: Quirúrgico. Tiroidectomía total cuando hay invasión extratiroidea, antecedente de exposición a radiaciones o no se cumplen criterios de hemitiroidectomía (papilar menor de 1 cm sin afección ganglionar). Diferencial: la radioablación con yodo se considera en todos los papilares y foliculares excepto estadio I y riesgo muy bajo.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con carcinoma folicular que será radioablativo con yodo-131. ¿Qué debe hacerse antes?

REVERSO: Suspender la hormona tiroidea para elevar la TSH antes de administrar el I-131. Diferencial: el seguimiento posterior usa la tiroglobulina como marcador en pacientes con tiroidectomía total y terapia radioablativa.

Cirrosis Hepática

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuáles son los cinco parámetros de la clasificación Child-Pugh y su estratificación?

REVERSO: Encefalopatía, ascitis, bilirrubina, albúmina y prolongación del tiempo de protrombina (o INR); A = 5-6 puntos, B = 7-9, C = 10-15. Diferencial: el modelo MELD tiene mayor precisión pronóstica y lo sustituye; pacientes con MELD mayor de 15 se consideran para trasplante hepático.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Cirrótico con ascitis y más de 250 leucocitos/mm³ en el líquido peritoneal. ¿Diagnóstico y tratamiento inicial?

REVERSO: Peritonitis bacteriana espontánea: cefotaxima u ofloxacino por 10 días. Diferencial: tras sobrevivir un episodio se requiere profilaxis antibiótica a largo plazo con trimetoprim-sulfametoxazol, ofloxacino o norfloxacin.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paracentesis de 6 litros en ascitis tensa. ¿Qué medida de soporte debe administrarse?

REVERSO: Infusión de albúmina: 8-10 g por cada litro extraído por encima de 5 litros. Diferencial: en ascitis moderada la base es restricción de sodio (menos de 2 g/día) con espironolactona o furosemina.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento de la encefalopatía hepática y qué hallazgo define al grado II?

REVERSO: Control de factores precipitantes y lactulosa, con antibióticos entéricos reductores de la flora productora de amonio si se requiere; el grado II cursa con asterixis y conducta inapropiada. Diferencial: el diagnóstico es clínico; no se recomienda determinación rutinaria de amonio y el EEG muestra ondas trifásicas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es la complicación grave más frecuente de la cirrosis hepática?

REVERSO: La hemorragia gastrointestinal originada en las várices esofágicas, consecuencia de la hipertensión portal (gradiente mayor de 6 mmHg). Diferencial: la ascitis es la complicación más común en general (85% de las ascitis ocurren en cirróticos) y la prevención del primer sangrado se hace con bloqueadores β no selectivos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué hallazgos de laboratorio definen el fracaso sintético hepático y qué refleja la trombocitopenia?

REVERSO: Hipoalbuminemia, coagulopatía (prolongación del TP/INR) e hiperbilirrubinemia. Diferencial: la trombocitopenia refleja hipersplenismo por hipertensión portal, no fracaso sintético.

Deficiencia de G6PD

Tarjeta 1 -- FRENTE: Varón con ictericia y anemia aguda tras exposición oxidante. ¿Qué muestra el frotis y la prueba de Coombs?

REVERSO: Células mordidas en el extendido de sangre periférica y Coombs negativo (hemólisis no esferocítica). Diferencial: la esferocitosis hereditaria muestra esferocitos; la anemia hemolítica autoinmune, Coombs directo positivo.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué herencia tiene la deficiencia de G6PD y en qué poblaciones es más frecuente?

REVERSO: Trastorno ligado al cromosoma X; predomina en poblaciones africanas, del Medio Oriente, mediterráneas y asiáticas. Diferencial: la mayoría de las personas con la deficiencia cursan asintomáticas toda la vida.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué fármacos desencadenan crisis hemolíticas oxidativas en el déficit de G6PD?

REVERSO: Primaquina, dapsona, sulfonamidas y sulfonas, nitrofurantoína, quinolonas, ácido acetilsalicílico, flutamida y vitamina K. Diferencial: otros desencadenantes son las infecciones, el consumo de habas, el infarto miocárdico y la cetoacidosis diabética.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio confirmatorio de la deficiencia de G6PD y cuándo debe realizarse?

REVERSO: El análisis cuantitativo de la actividad de G6PD (escrutinio: prueba de mancha fluorescente), obtenido 2-3 meses después de una crisis hemolítica, transfusión o tratamiento de ictericia neonatal. Diferencial: obtenerlo antes genera falsos negativos.

Diabetes Mellitus Tipo 2

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuáles son los cuatro criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo 2?

REVERSO: Glucosa en ayuno igual o mayor de 126 mg/dL; glucosa a las 2 h poscarga igual o mayor de 200 mg/dL; glucosa aleatoria igual o mayor de 200 mg/dL con síntomas; HbA1c igual o mayor de 6.5%. Diferencial: prediabetes es glucosa en ayuno de 100-125 mg/dL o HbA1c de 5.7-6.4%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el fármaco de primera línea en la diabetes mellitus tipo 2?

REVERSO: Metformina. Diferencial: la segunda línea se elige según riesgo cardiovascular, IMC y costo (inhibidores de SGLT2 y de DPP-4, agonistas de GLP-1, sulfonilureas, tiazolidinedionas o insulina).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuáles son las metas terapéuticas de la diabetes mellitus tipo 2?

REVERSO: HbA1c menor de 7%; glucosa en ayuno de 70-130 mg/dL; posprandial menor de 180 mg/dL; LDL menor de 100 mg/dL (menor de 70 si hay riesgo cardiovascular); presión arterial menor de 130/80 mmHg. Diferencial: en el adulto mayor frágil o con demencia se individualiza a HbA1c de 7.5-8.5%.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿En qué pacientes prediabéticos está indicada la metformina?

REVERSO: Con IMC alto, edad menor de 60 años o antecedente de diabetes gestacional. Diferencial: la base de la prevención son los cambios en el estilo de vida.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué complicaciones microvasculares y macrovasculares produce la diabetes mellitus tipo 2?

REVERSO: Microvasculares: retinopatía, nefropatía y neuropatía periférica. Macrovasculares: cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. Diferencial: las complicaciones infecciosas incluyen pie diabético, candidiasis genital y pielonefritis enfisematosa.

Drepanocitosis

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué mutación y herencia causan la drepanocitosis?

REVERSO: Herencia autosómica recesiva: sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena β de globina, que genera la hemoglobina S. Diferencial: la anemia de células falciformes es el genotipo HbSS; el heterocigoto (rasgo) no sufre crisis dolorosas.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de confirmación diagnóstica de la drepanocitosis?

REVERSO: La electroforesis de hemoglobina, complementada con hemograma, conteo reticulocitario y extendido de sangre periférica. Diferencial: el tamizaje neonatal se realiza en papel filtro.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Lactante de 7 meses con inflamación dolorosa de manos y pies. ¿Qué manifestación es y por qué debutó a esa edad?

REVERSO: Dactilitis (síndrome mano-pie), la presentación aguda más común; aparece al disminuir la hemoglobina fetal entre los 4-6 meses. Diferencial: los neonatos suelen ser asintomáticos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es la profilaxis infecciosa obligatoria en el paciente con drepanocitosis y cuál es su base?

REVERSO: Penicilina desde los 2 meses hasta los 5 años, más vacunación contra influenza, meningococo y neumococo, por la asplenia funcional que se instala en la niñez temprana por infartos esplénicos repetidos. Diferencial: los gérmenes de mayor riesgo son *Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus* y *Salmonella*.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuál es el fármaco modificador de la enfermedad en la drepanocitosis y su mecanismo?

REVERSO: La hidroxiurea: induce la síntesis de hemoglobina fetal, reduciendo la frecuencia de crisis dolorosas y los requerimientos transfusionales. Diferencial: el único tratamiento curativo es el trasplante de médula ósea.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Varón con drepanocitosis y priapismo. ¿Cuál es el manejo inicial?

REVERSO: Consulta urológica inmediata, hidratación intravenosa, oxígeno suplementario si hay hipoxia documentada y opioides parenterales. Diferencial: el síndrome torácico agudo (dolor y fiebre por formación de drepanocitos en la vasculatura pulmonar) también requiere referencia urgente.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el criterio espirométrico diagnóstico de la EPOC?

REVERSO: Relación VEF1/CVF post-broncodilatador menor de 0.7, con limitación persistente (no reversible) del flujo aéreo. Diferencial: en el asma la obstrucción es variable y reversible con aumento del VEF1 mayor de 12% y 200 ml.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Fumador de 42 años con disnea y obstrucción al flujo aéreo. ¿Qué estudio adicional debe considerarse?

REVERSO: Determinación de alfa-1-antitripsina, indicada en menores de 45 años y sin antecedentes de exposición a humo. Diferencial: la deficiencia de alfa-1-antitripsina es el etiotipo genético de la EPOC.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento inicial del grupo C de GOLD (poco sintomático, alto riesgo de exacerbación)?

REVERSO: Un antagonista muscarínico de acción prolongada (LAMA, como tiotropio), por su baja probabilidad de exacerbación. Diferencial: en el grupo D se sugiere LAMA, aunque la combinación

LAMA-LABA puede preferirse con disnea severa (CAT mayor de 20).

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuáles son las indicaciones de oxígeno domiciliario en la EPOC y su duración mínima?

REVERSO: PaO₂ menor de 55 mmHg o SaO₂ menor de 88%; o PaO₂ de 55-60 mmHg con hipertensión arterial pulmonar, poliglobulia o trastornos del ritmo cardiaco; uso por más de 16 horas al día. Diferencial: el cese del hábito tabáquico es la única intervención que ha demostrado disminuir la progresión.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Exacerbación de EPOC con PaCO₂ mayor de 45 mmHg y pH menor de 7.30. ¿Cuál es el manejo ventilatorio?

REVERSO: Ventilación no invasiva con BiPAP, que reduce mortalidad y porcentaje de intubación, con oxígeno de bajo flujo dirigido a SaO₂ de 88-92%. Diferencial: la VNI está contraindicada si la vía aérea no es protegible o la escala de Glasgow es menor de 10.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de la exacerbación moderada de la EPOC?

REVERSO: Broncodilatadores SABA/SAMA más prednisona 40 mg al día por 5-7 días, con antibióticos según criterios de Anthonisen. Diferencial: el fracaso terapéutico se define por deterioro clínico después de 72 horas o ausencia de mejoría a los 7-10 días.

Enfermedad Renal Crónica

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la definición diagnóstica de la enfermedad renal crónica?

REVERSO: TFG menor de 60 ml/min/1.73 m², marcadores de daño renal (albuminuria mayor de 30 mg/24 h, sedimento anormal, imagen o histología) o ambos, con duración igual o mayor de 3 meses. Diferencial: el estadio 5 (TFG menor de 15) define falla renal que requiere terapia de reemplazo renal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica en México y la segunda en frecuencia?

REVERSO: Diabetes mellitus (48.5%), seguida de hipertensión arterial (19%). Diferencial: las glomerulopatías crónicas ocupan el tercer lugar (12.7%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que enlentece la progresión de la enfermedad renal crónica?

REVERSO: IECA o ARA II, que reducen la proteinuria, con presión arterial menor de 130/80 mmHg. Diferencial: deben evitarse AINE y contraste yodado, con restricción proteica menor de 1 g/kg/día y de sodio de 1-2 g/día.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la eritropoyetina en la enfermedad renal crónica?

REVERSO: Cuando la hemoglobina es menor de 10 g/dL en ausencia de deficiencia de hierro. Diferencial: la anemia de la insuficiencia renal crónica es normocítica normocítica y a menudo requiere hierro oral o parenteral para responder.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuáles son las indicaciones de iniciar terapia de reemplazo renal?

REVERSO: TFG menor de 15 ml/min/1.73 m², síndrome urémico severo, acidosis metabólica refractaria, hipercalemia refractaria, sobrecarga de volumen refractaria y encefalopatía urémica. Diferencial: la osteodistrofia renal se maneja con quelantes de fósforo y vitamina D activa, manteniendo el producto calcio por fósforo menor de 60-70.

Enfermedad Vascular Cerebral Hemorrágica

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia intracerebral?

REVERSO: La hipertensión arterial sistémica (causa número uno), seguida de traumatismos, diátesis hemorrágica y angiopatía amiloide. Diferencial: en la hemorragia subaracnoidea no traumática dominan la ruptura de aneurisma sacular (80% de los casos) y las malformaciones vasculares.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuál es el estudio de confirmación de la hemorragia intracerebral aguda y cómo se estima el volumen del hematoma?

REVERSO: La tomografía computarizada simple, estándar de referencia diagnóstico; el volumen se estima con la fórmula ABC/2 y predice expansión y mortalidad temprana. Diferencial: la angio-TC debe realizarse de forma aguda para buscar una causa macrovascular subyacente.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Paciente anticoagulado con warfarina que presenta hemorragia intracerebral. ¿Cómo se revierte la anticoagulación?

REVERSO: Vitamina K intravenosa 10 mg más concentrado de complejo de protrombina de cuatro factores, con objetivo de INR menor de 1.3. Diferencial: dabigatrán se revierte con idarucizumab y los inhibidores del factor Xa con andexanet alfa.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Hemorragia intracerebral aguda con presión sistólica de 180 mmHg e inicio hace 3 horas. ¿Cuál es el objetivo de presión arterial y con qué fármacos?

REVERSO: Reducir a 130-140 mmHg, en el plazo de una hora, con nitroglicerina o labetalol intravenosos. Diferencial: en la hemorragia subaracnoidea el objetivo es sistólica menor de 160 mmHg con nicardipino, labetalol o clevidipino; el nitroprusiato y la nitroglicerina deben evitarse por aumentar la presión intracraneal.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la evacuación descompresiva quirúrgica en la hemorragia intracerebral?

REVERSO: En hemorragia cerebelosa mayor de 3 cm de diámetro, o en hematomas menores con compresión del tronco encefálico o hidrocefalia por obstrucción ventricular. Diferencial: la hemorragia intracerebral inicia gradualmente en minutos u horas, a diferencia del comienzo abrupto de la hemorragia subaracnoidea.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuál es el síntoma cardinal de la hemorragia subaracnoidea y cuál es su estudio de confirmación?

REVERSO: Cefalea en trueno (el peor dolor de cabeza de su vida), con vómito y signos de irritación meníngea; la TC simple en las primeras 6 horas tiene sensibilidad de 98% y si no es definitiva se practica punción lumbar con xantocromía, patognomónica. Diferencial: en la hemorragia intracerebral la cefalea y el déficit progresan gradualmente.

Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con déficit neurológico focal de 2 horas de evolución. ¿Cuál es el tratamiento de revascularización y su dosis?

REVERSO: rt-PA (alteplasa) intravenoso antes de 4.5 horas del inicio: 0.9 mg/kg (máximo 90 mg), con bolo inicial del 10% de la dosis. Diferencial: entre 4.5 y 9 horas solo con discordancia DWI/FLAIR; la glucosa sérica es el único estudio de laboratorio que debe preceder a la trombólisis.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Cuáles son las principales contraindicaciones absolutas para la trombólisis intravenosa en la EVC isquémica?

REVERSO: Presión arterial mayor de 185/110 mmHg, plaquetas menores de 100,000/mm³, INR mayor de 1.7, hemorragia intracraneal previa, glucosa menor de 50 mg/dl, cirugía intracraneal reciente e infarto multilobar (hipodensidad mayor de 1/3 del hemisferio). Diferencial: la TC de cráneo sin contraste primero excluye hemorragia intracerebral, contraindicación absoluta.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para la trombectomía mecánica temprana?

REVERSO: Oclusión proximal de la arteria carótida interna o de la cerebral media (segmento M1), menos de 6 horas de evolución, NIHSS mayor de 6, ASPECTS mayor de 6, Rankin modificada de 0 a 1 y edad mayor de

18 años. Diferencial: entre 6 y 24 horas se extiende con los criterios de los estudios DEFUSE 3 o DAWN.

Tarjeta 4 -- FRENTE: EVC isquémico no candidato a trombólisis con presión arterial de 230/125 mmHg. ¿Cómo se maneja la presión arterial?

REVERSO: Antihipertensivos intravenosos (labetalol o nicardipino) si la presión sistólica es mayor de 220 mmHg o la diastólica mayor de 120, con reducción controlada de no más de 15% de la basal en las primeras 24 horas. Diferencial: durante la trombólisis la meta es mantenerla por debajo de 180/105 mmHg durante al menos 24 horas.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Déficit neurológico totalmente reversible de 30 minutos, sin infarto en la imagen. ¿Diagnóstico, escala de estratificación y manejo antiagregante?

REVERSO: Isquemia cerebral transitoria (recuperación total en 24 horas o menos, sin infarto en imagen); se calcula el puntaje ABCD2, con admisión hospitalaria si es igual o mayor de 3. Diferencial: con ABCD2 mayor de 4 (alto riesgo) se indica aspirina 81 mg más clopidogrel 75 mg al día por 21-90 días.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con fibrilación auricular que sufrió un EVC isquémico. ¿Cuál es la prevención secundaria de elección?

REVERSO: Anticoagulación oral: antagonistas de la vitamina K, apixabán o dabigatrán, con el más alto nivel de evidencia. Diferencial: en estenosis carotídea sintomática mayor de 70% se indica endarterectomía carotídea o colocación de stent.

Enfermedad Vascular Cerebral

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es la definición de enfermedad vascular cerebral?

REVERSO: Episodio súbito de disfunción focal cerebral, retiniana o medular, con duración mayor de 24 horas, o de cualquier duración si la imagen o la autopsia demuestran infarto o hemorragia. Diferencial: es una emergencia médica tiempo-dependiente; el retraso se asocia con menor recuperación.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué proporción representan la isquemia, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea entre todas las EVC?

REVERSO: Isquemia 62%, hemorragia intracerebral 28% y hemorragia subaracnoidea 10%. Diferencial: la EVC hemorrágica en conjunto comprende 20-30% de todos los eventos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuáles son los cinco factores de riesgo modificables que explican la mayor parte de los casos de EVC?

REVERSO: Hipertensión arterial, alimentación incorrecta, sedentarismo, obesidad y tabaquismo; explican el 90% de los casos y del costo global. Diferencial: el control multidimensional reduce en 80% el riesgo de nuevos eventos similares.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuál es el principal factor de riesgo no modificable de la EVC?

REVERSO: La edad avanzada. Diferencial: el riesgo de sufrir una EVC a lo largo de la vida a partir de los 25 años es de aproximadamente 25%.

Enfermedad de Wilson

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el defecto genético de la enfermedad de Wilson y su patrón de herencia?

REVERSO: Mutación del gen ATP7B (transportador de cobre dependiente de ATP), autosómica recesiva; produce excreción biliar inadecuada de cobre con acumulación en hígado, cerebro, riñón y córnea. Dato diferencial: la hemocromatosis también es autosómica recesiva, pero acumula hierro.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Varón con enfermedad hepática sin causa aparente más trastorno neuropsiquiátrico: ¿qué diagnóstico diferencial obligado debe considerarse?

REVERSO: Enfermedad de Wilson; además figura como causa secundaria a excluir en la hepatopatía grasa no alcohólica. Dato diferencial: los anillos de Kayser-Fleischer aparecen en 95% con afectación neurológica o psiquiátrica.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué hallazgo ocular se encuentra en 95% de los pacientes con la forma neurológica de la enfermedad de Wilson?

REVERSO: Anillos de Kayser-Fleischer (depósito anular de cobre en la córnea); sólo en 50-65% de la forma hepática. Diferencial: es uno de los criterios diagnósticos junto con la historia familiar.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué niveles séricos disminuidos caracterizan a la enfermedad de Wilson?

REVERSO: Ceruloplasmina y cobre séricos bajos (la ceruloplasmina es inestable sin cobre incorporado). Dato diferencial: la excreción urinaria de cobre en 24 h está elevada o el reto con penicilamina la incrementa 10 veces.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué tipo de anemia hemolítica acompaña a la enfermedad de Wilson?

REVERSO: Anemia hemolítica con prueba de Coombs negativa. Dato diferencial: la anemia hemolítica autoinmune es Coombs positiva; es uno de los criterios (requieren >2) diagnósticos.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la enfermedad de Wilson.

REVERSO: Quelación con D-penicilamina + piridoxina (previene la deficiencia de vitamina B6) y restricción dietética de cobre (mariscos, chocolate, hígado). Diferencial: si hay intolerancia (20%) o empeoramiento neurológico, acetato de cinc; el trasplante hepático es curativo.

Esferocitosis Hereditaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué hallazgo del hemograma distingue a la esferocitosis hereditaria de otras anemias hemolíticas?

REVERSO: Elevación de la concentración corpuscular media de hemoglobina ≥ 36 pg/célula, con reticulocitosis e hiperbilirrubinemia no conjugada. Diferencial: es la anemia hemolítica hereditaria más frecuente en México (GPC).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Prueba diagnóstica de confirmación de la esferocitosis hereditaria.

REVERSO: Fragilidad osmótica con cloruro de sodio en sangre incubada + extendido con esferocitos sin palidez central, tras descartar ferropenia, hemólisis autoinmune e ictericia obstructiva.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dosis de ácido fólico en el tratamiento de soporte de la esferocitosis hereditaria.

REVERSO: Ácido fólico 2.5 mg/día en menores de 5 años y 5 mg/día en mayores de 5 años (GPC); transfusión de eritrocitarios en anemia sintomática con infecciones, crisis aplásica o gestantes.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la esplenectomía en esferocitosis hereditaria y cómo debe prepararse?

REVERSO: Formas moderadas o graves o litiasis vesicular sintomática; preferentemente mayores de 6 años, con inmunizaciones contra neumococo, meningococo y Hib 2 semanas antes y profilaxis antibiótica 6 meses después (betalactámicos; macrólidos si alergia).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Complicaciones de la esferocitosis hereditaria.

REVERSO: Litiasis vesicular, crisis aplásica por parvovirus B19 y anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Paciente con esferocitos en el extendido y Coombs directo positivo: ¿qué diagnóstico debe excluirse primero?

REVERSO: Anemia hemolítica autoinmune (también cursa con esferocitos); la esferocitosis hereditaria se distingue por antecedente familiar y Coombs negativo. Otro diferencial: deficiencia de G6PD.

Gonorrea (*Neisseria gonorrhoeae*)

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el agente etiológico y el periodo de incubación de la gonorrea?

REVERSO: *Neisseria gonorrhoeae*, diplococo gramnegativo intracelular; incubación de 2-5 días. Diferencial: alto riesgo en adolescentes y adultos jóvenes.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudio diagnóstico estándar actual de la gonorrea.

REVERSO: NAAT (pruebas de amplificación de ácidos nucleicos); la tinción de Gram tiene alta sensibilidad en hombres por la descarga uretral; el cultivo se hace en Thayer-Martin.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de elección de la gonorrea.

REVERSO: Ceftriaxona + azitromicina; la azitromicina cubre la coinfección por *Chlamydia trachomatis*, presente en un alto porcentaje de casos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Complicación ginecológica principal de la gonorrea en la mujer.

REVERSO: Enfermedad inflamatoria pélvica, abscesos tuboováricos y salpingitis, causa de infertilidad y embarazo ectópico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué proporción de mujeres con gonorrea es asintomática?

REVERSO: 50%; con síntomas: flujo vaginal, dolor abdominal y metrorragia. Diferencial: el hombre cursa con descarga uretral purulenta y disuria.

Hemocromatosis Hereditaria

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Cuál es el defecto genético de la hemocromatosis hereditaria?

REVERSO: Mutación del gen HFE (C282Y), autosómica recesiva; es la enfermedad hepática hereditaria más frecuente en caucásicos y reduce la producción hepática de hepcidina.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estudios de laboratorio iniciales que sugieren hemocromatosis hereditaria.

REVERSO: Elevación de ferritina y saturación de transferrina; el diagnóstico se concreta con análisis mutacional de HFE y, de requerirse, índice férrico hepático >2.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la hemocromatosis hereditaria.

REVERSO: Flebotomía semanal. Dato diferencial: los quelantes de hierro no benefician a la mayoría de estos pacientes (a diferencia de la sobrecarga por transfusiones).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Varón con diabetes, pigmentación bronceada y artritis: ¿qué patología sospechar y qué complicación hepática temer?

REVERSO: Hemocromatosis hereditaria; complica con cirrosis y carcinoma hepatocelular (14%). Diferencial: descartar porfiria cutánea tardía y sobrecarga iatrogénica de hierro.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué infecciones son más frecuentes en pacientes con sobrecarga de hierro?

REVERSO: *Yersinia enterocolitica* y pseudotuberculosis, *Vibrio vulnificus* y *Listeria monocytogenes* (organismos con predilección por ambientes ricos en hierro).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cuándo está indicada la biopsia hepática en hemocromatosis?

REVERSO: Sólo en sujetos homocigotos con ferritina sérica >1000 µg/L; puede omitirse en menores de 40 años con mutación de HFE detectable y transferrina elevada.

Hepatitis Autoinmune

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué autoanticuerpos definen la hepatitis autoinmune tipo 1 y la tipo 2?

REVERSO: Tipo 1 (60-90%): ANA y/o ASMA; tipo 2 (<10-15%, niños y adolescentes): LKM-1 y/o LC-1, con mala respuesta y recaídas. Diferencial: los anticuerpos antimitocondria están ausentes en la HA.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgo histológico característico de la hepatitis autoinmune.

REVERSO: Hepatitis de interfase con infiltrado portal de células plasmáticas; la biopsia hepática debe realizarse en todos los pacientes con sospecha.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento estándar de primera elección de la hepatitis autoinmune con dosis.

REVERSO: Prednisona 30 mg/día (reducir a 10 mg/día a las 4 semanas) + azatioprina 50 mg/día o 1-2 mg/kg/día; segunda línea si intolerancia a azatioprina: prednisona + micofenolato de mofetilo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Indicaciones absolutas de tratamiento en hepatitis autoinmune.

REVERSO: Transaminasas >10 veces el LSN; >5 veces con gammaglobulinas o IgG >2 veces el LSN; necrosis en puente en biopsia; síntomas incapacitantes.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué fármacos precipitan la mayoría de las hepatitis autoinmunes inducidas por fármacos?

REVERSO: Minociclina y nitrofurantoína (90% de los casos de HA inducida por fármacos).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Enfermedad autoinmune concomitante más frecuente en la hepatitis autoinmune.

REVERSO: Tiroiditis de Hashimoto; predomina en mujeres (relación 4:1 en tipo 1 y 10:1 en tipo 2), con mayor frecuencia entre los 20-30 años.

Hepatitis Viral

Tarjeta 1 -- FRENTE: Paciente con HBsAg positivo, anti-HBc IgM positivo y anti-HBs negativo: ¿qué interpretación serológica tiene?

REVERSO: Infección aguda por VHB; si el HBsAg persiste >6 meses con anti-HBc IgM negativo y total positivo es infección crónica. Diferencial: anti-HBs positivo aislado = vacunado.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Marcador serológico de la infección aguda por virus de la hepatitis A.

REVERSO: Anti-VHA IgM (sensibilidad 100%; se detecta desde los 15 días y persiste hasta 6 meses); el IgG sólo documenta infección previa. Diferencial: transmisión fecal-oral y curso autolimitado.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio inicial y prueba confirmatoria de la hepatitis C.

REVERSO: Anti-VHC (sensibilidad 97-100%) como inicial y PCR como confirmatoria (detectable desde la 1-2ª semana); falsos negativos de anticuerpos en inmunosupresión grave, hemodiálisis e hipoagammaglobulinemia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento de elección actual de la hepatitis C crónica.

REVERSO: Antivirales de acción directa pangenotípicos: glecaprevir/pibrentasvir por 8 semanas o sofosbuvir/velpatasvir por 12 semanas; la cura (respuesta viral sostenida) se confirma con PCR indetectable 12 semanas después de terminar.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Tratamiento de primera línea de la hepatitis B crónica y único permitido en el embarazo.

REVERSO: Tenofovir (TDF/TAF) o entecavir; en embarazadas el único permitido es el TDF; en cirrosis descompensada se prefiere entecavir. Diferencial: el PegIFN- α está contraindicado en cirrosis.

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Qué virus de la hepatitis requiere al VHB para ensamblarse y qué proporción de hepatitis fulminantes causa?

REVERSO: El VHD (Deltavirus); es responsable del 40% de las hepatitis fulminantes. Diferencial serológico: en la coinfección aguda VHB/VHD el anti-HBc IgM es positivo; en la superinfección aguda es negativo.

Hepatopatía Alcohólica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Patrón bioquímico hepático típico de la hepatopatía alcohólica.

REVERSO: AST/ALT >2 (razones >3 altamente sugestivas) y transaminasas que rara vez alcanzan 300 U/L. Diferencial: la hepatopatía grasa no alcohólica cursa con AST/ALT <1.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué puntaje de Maddrey indica hepatitis alcohólica grave y con qué fármacos se trata?

REVERSO: Maddrey >32 o encefalopatía hepática: corticosteroides, prednisolona 40 mg/día o metilprednisolona 32 mg/día, para reducir la mortalidad a corto plazo. Diferencial: sin mejoría en 7 días puede valorarse trasplante hepático precoz.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuánto alcohol produce hígado graso y cuál es su reversibilidad?

REVERSO: Hígado graso en ~90% de quienes ingieren >60 g/día; es asintomático, autolimitado y reversible tras 4-6 semanas de abstinencia.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Escalas pronósticas de la hepatitis alcohólica y criterio de trasplante.

REVERSO: Pronóstico precario con Maddrey >32, MELD >18 o Glasgow >8; el trasplante se considera en Child-Pugh clase C o MELD >15.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgos histológicos característicos de la hepatopatía etílica.

REVERSO: Infiltrados polimorfonucleares, edema hepatocitario centrolobulillar, esteatosis, cuerpos de Mallory y fibrosis; además γ GT elevada y volumen corpuscular medio alto. Diferencial: si se requiere biopsia, por vía transyugular por riesgo de hemorragia.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Medida terapéutica universal en la hepatopatía alcohólica.

REVERSO: La abstinencia es la base del manejo; además suplementación de complejo B y evitar diuréticos y nefrotóxicos por riesgo de lesión renal aguda.

Hepatopatía Grasa No Alcohólica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Patrón de transaminasas que orienta a hepatopatía grasa no alcohólica.

REVERSO: Elevación leve con relación AST/ALT <1 (predomina ALT). Diferencial: una razón AST/ALT >2 sugiere forma secundaria, como la hepatopatía alcohólica.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de la HGNA.

REVERSO: Evidencia histológica o por imagen de esteatosis (>5% de hepatocitos) más exclusión de causas secundarias: alcohol, fármacos (amiodarona, metotrexato, tamoxifeno, corticoides, valproato) y enfermedad de Wilson.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Estudio de imagen de primera línea para la esteatosis hepática.

REVERSO: Ultrasonido (sensibilidad 60-94%, especificidad 66-97%); la TC y la resonancia carecen de sensibilidad para esteatohepatitis o fibrosis.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico de la esteatohepatitis no alcohólica (NASH).

REVERSO: Pioglitazona y vitamina E (alfa tocoferol), junto con pérdida ponderal lenta de 10% y control glucémico y lipídico.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Qué define histológicamente a la NASH?

REVERSO: Necroinflamación con daño hepatocelular y balonización, con fibrosis de intensidad variable; el estándar para graduar la fibrosis es la biopsia hepática.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Complicaciones hepáticas de la NASH.

REVERSO: Cirrosis, hipertensión portal y carcinoma hepatocelular (incidencia acumulativa a 5 años de 8%); la HGNA es además factor independiente de riesgo cardiovascular.

Hipertensión Arterial Sistémica

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterio diagnóstico de hipertensión arterial grado 2.

REVERSO: PAS ≥ 140 y/o PAD ≥ 90 mmHg persistentes; la crisis hipertensiva es $>180/>120$. Diferencial: la HTA grado 1 es 130-139/80-89.

Tarjeta 2 -- FRENTE: ¿Qué proporción de la hipertensión arterial es esencial y qué proporción es secundaria?

REVERSO: Esencial o primaria 90-95% (multifactorial); secundaria 5-10% (renal, endocrina, farmacológica), por lo que debe buscarse causa identificable ante datos atípicos.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico de primera línea de la hipertensión arterial.

REVERSO: IECA o ARA II; también calcioantagonistas y diuréticos tiazídicos; en hipertensión grado 2 se prefiere la combinación de dos fármacos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Meta de presión arterial en el seguimiento de la hipertensión.

REVERSO: $<140/90$ mmHg, o $<130/80$ mmHg si existen comorbilidades; el diagnóstico requiere al menos dos lecturas en dos ocasiones y evaluar daño a órgano blanco.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Medidas no farmacológicas de primera línea en hipertensión.

REVERSO: Dieta DASH, sal <2.3 g/día, reducción de peso, ejercicio regular, limitar alcohol y cesar tabaquismo.

Hipotiroidismo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Perfil de laboratorio del hipotiroidismo primario clínico.

REVERSO: TSH elevada con T4 libre baja; en el subclínico, TSH elevada con T4L normal. Diferencial: el hipotiroidismo central ($<1\%$) cursa con TSH baja o inapropiadamente normal (la TSH no es confiable ahí).

Tarjeta 2 -- FRENTE: Causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas con yodo suficiente y su marcador serológico.

REVERSO: Tiroiditis de Hashimoto (destrucción autoinmune); el anticuerpo antimicrosomal tiene sensibilidad de 90%. Diferencial: glándula firme y prominente con lóbulo piramidal a la exploración.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Dosis de inicio de levotiroxina en hipotiroidismo.

REVERSO: 1.6-1.8 $\mu\text{g/kg/día}$; adulto mayor sano 12.5-25 $\mu\text{g/día}$; adulto mayor con cardiopatía 0.5 $\mu\text{g/kg/día}$; ajustes de 12.5-25 μg guiados por TSH (el indicador más preciso).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Cuadro clínico del coma mixedematoso.

REVERSO: Hipotermia, hipotensión, bradicardia y alteración del estado mental; factores de riesgo: edad mayor y disfunción tiroidea prolongada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Indicaciones de levotiroxina en el hipotiroidismo subclínico.

REVERSO: Niños, gestantes, TSH >10 μ U/ml, TSH 4.5-10 μ U/ml con manifestaciones clínicas o anti-TPO elevados; también hipercolesterolemia significativa.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Hallazgos de laboratorio adicionales frecuentes en hipotiroidismo.

REVERSO: Hiponatremia, anemia macrocítica, aumento de CPK, colesterol y prolactina. Diferencial: en el embarazo, el clínico es TSH >10 mU/L y el subclínico TSH 2.5-10 mU/L con T4L normal (aumentar dosis 30%).

Infarto Agudo de Miocardio con Elevación del ST

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterio electrocardiográfico diagnóstico del IAMCEST.

REVERSO: Elevación nueva del ST en ≥ 2 derivaciones contiguas: ≥ 0.1 mV en todas excepto V2-V3; en V2-V3, >0.25 mV (hombres <40), >0.20 mV (hombres >40) y ≥ 0.15 mV (mujeres). Diferencial: un BRIHH nuevo con dolor precordial puede ser equivalente de IAMCEST.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Estrategia de reperfusión de elección y tiempos objetivo en IAMCEST.

REVERSO: ICP primaria: puerta-balón ≤ 60 min (≤ 90 min si se traslada al paciente), máx 120 min; si no es posible, fibrinólisis con tenecteplasa en bolo según peso (30-50 mg; reducir la mitad en mayores de 75 años).

Tarjeta 3 -- FRENTE: Clasificación Killip-Kimbal: qué define a las clases III y IV y su mortalidad hospitalaria.

REVERSO: III = edema agudo pulmonar (38%); IV = choque cardiogénico (81%). Diferencial: clase II = S3 y estertores basales (17%).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Antiagregación dual en la ICP primaria: fármacos y dosis de carga.

REVERSO: AAS 150-300 mg oral de carga (luego 75-100 mg/día) y clopidogrel 600 mg de carga (75 mg/día), durante 12 meses; 6 meses si alto riesgo hemorrágico (>75 años, enfermedad renal o hepática, plaquetas <100 mil/mcl).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Sospecha de complicación mecánica del IAMCEST: manifestaciones, ventana temporal y estudio.

REVERSO: Hipotensión súbita, recurrencia del dolor, nuevos soplos, ingurgitación yugular o congestión pulmonar entre 48 h y 14 días (rotura de pared libre, tabique interventricular o músculo papilar); confirmar con ecocardiograma y tratar quirúrgicamente.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Estatina y objetivo de LDL tras un IAMCEST.

REVERSO: Atorvastatina 80 mg lo antes posible; c-LDL <55 mg/dl o reducción $>50\%$. Diferencial: oxígeno sólo si SatO₂ $<90\%$ o PaO₂ <60 mmHg (sin hipoxemia puede aumentar el tamaño del infarto).

Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Estrategia diagnóstica de la infección por VIH en el adulto.

REVERSO: Prueba inicial ELISA (o prueba rápida, de primera línea) seguida de confirmación por Western blot.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Esquema TARV recomendado en el embarazo después de las 8 semanas de gestación.

REVERSO: TDF/FTC o ABC/3TC + dolutegravir (DTG); antes de las 8 semanas: TDF/FTC + raltegravir (RAL), por riesgo potencial (no contraindicante) de alteraciones del tubo neural con DTG.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Vía de resolución en embarazada con VIH y carga viral >1000 copias/mL.

REVERSO: Cesárea electiva en la semana 38 (también si carga viral desconocida, sin TARV o sólo monoterapia con ZDV). Diferencial: con carga viral <50 copias/mL puede considerarse parto vaginal.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Profilaxis intraparto preferida en la infección por VIH.

REVERSO: Zidovudina intravenosa iniciada 4 h antes de la resolución: 2 mg/kg en la primera hora, después 1 mg/kg/h hasta el nacimiento; la nevirapina no está recomendada.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Profilaxis del recién nacido expuesto a VIH según riesgo.

REVERSO: En las primeras 6-12 h de vida: riesgo bajo, ZDV por 4 semanas; riesgo alto, ZDV+3TC+NVP (ZDV/3TC 4 semanas y NVP 2 semanas).

Tarjeta 6 -- FRENTE: ¿Cómo se diagnostica la infección por VIH en menores de 18 meses?

REVERSO: Con prueba virológica (PCR de carga viral), no con ELISA, por el paso transplacentario de anticuerpos maternos; PCR a los 14-21 días, entre 1-2 meses y entre 4-6 meses. Diferencial: la lactancia materna está contraindicada en la madre con VIH.

Nefropatía Diabética

Tarjeta 1 -- FRENTE: Lesión histológica nodular característica de la nefropatía diabética.

REVERSO: Glomeruloesclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson (material Schiff-positivo en la periferia glomerular); también glomeruloesclerosis difusa e hialinización arteriolar.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Terminología ADA actual de la albuminuria en diabetes mellitus.

REVERSO: Albuminuria A2: 30-299 mg/g (sustituye a microalbuminuria) y A3: ≥ 300 mg/g (sustituye a macroalbuminuria), medida como cociente albúmina/creatinina.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo se considera persistente la albuminuria para diagnosticar nefropatía diabética?

REVERSO: Persistente en ≥ 2 muestras, tras descartar causas transitorias: fiebre, ejercicio, infecciones, cetoacidosis, hiperglucemia aguda e insuficiencia cardíaca congestiva.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Tratamiento farmacológico de primera línea de la nefropatía diabética.

REVERSO: IECA o ARA II, con presión arterial $<130/80$ mmHg y HbA1c $<7\%$; evitar nefrotóxicos (AINE, medios de contraste).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterios de referencia a segundo nivel en nefropatía diabética.

REVERSO: ERC en estadio ≥ 3 (TFG <60 mL/min/1.73 m²), albuminuria persistente pese al tratamiento o sospecha de nefropatía no diabética.

Nódulo Tiroideo

Tarjeta 1 -- FRENTE: Primer estudio de laboratorio ante un nódulo tiroideo y conducta según el resultado.

REVERSO: TSH: si está suprimida, gammagrafía tiroidea con yodo; si es normal o elevada, la gammagrafía carece de utilidad y se procede a T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Método de confirmación histológica del nódulo tiroideo sospechoso.

REVERSO: Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF): en nódulos sólidos hipoeoicos ≥ 1 cm de alto riesgo, >20 mm de riesgo intermedio; no en lesiones puramente quísticas.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Características ecográficas de alto riesgo de malignidad del nódulo tiroideo.

REVERSO: Hipoeogenicidad marcada, márgenes irregulares o espiculados, microcalcificaciones, forma más alta que ancha, hipervascularidad y crecimiento extratiroideo; con cualquiera, riesgo de 50-90% y muestreo citológico.

Tarjeta 4 -- FRENTE: ¿Qué proporción de nódulos tiroideos es benigna y cuál es el riesgo de los hipofuncionantes?

REVERSO: 90-95% son benignos y asintomáticos (no se recomienda escrutinio poblacional); los hiperfuncionantes rara vez son malignos y los hipofuncionantes, en 8-12%.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Conducta ante una BAAF concluyente de malignidad.

REVERSO: Tiroidectomía total; ante citología indeterminada con sospecha ecográfica alta, hemitiroidectomía. Diferencial: la tiroglobulina no se recomienda; la calcitonina sólo si se sospecha carcinoma medular o MEN2.

Sepsis y Choque Séptico

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios de la escala qSOFA para sospecha de sepsis.

REVERSO: ≥ 2 de: frecuencia respiratoria ≥ 22 rpm, alteración del estado mental y PAS ≤ 100 mmHg; aplica principalmente fuera de la UCI. Diferencial: el SOFA diagnostica sepsis con incremento ≥ 2 puntos sobre el basal.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Definición de choque séptico (Sepsis-3).

REVERSO: Sepsis que requiere vasopresores para mantener PAM ≥ 65 mmHg con lactato > 2 mmol/L a pesar de resucitación hídrica adecuada.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Reanimación inicial del choque séptico y tiempo límite del antibiótico.

REVERSO: Cristaloides 30 mL/kg en las primeras 3 h y antibiótico empírico de amplio espectro dentro de la primera hora, con hemocultivos previos.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Vasopresor de primera línea en el choque séptico.

REVERSO: Norepinefrina; segunda línea vasopresina o epinefrina; dopamina sólo en casos seleccionados y sin uso renal-protector. Diferencial: dobutamina si hay disfunción miocárdica.

Tarjeta 5 -- FRENTE: ¿Cuándo se indica hidrocortisona en el choque séptico y con qué dosis?

REVERSO: Sólo si el choque es refractario a la resucitación y los vasopresores: hidrocortisona 200 mg/día.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Valor de lactato sérico que indica hipoperfusión tisular.

REVERSO: > 2 mmol/L; la hipoperfusión puede existir sin hipotensión franca. Diferencial: mortalidad de 20-50% en sepsis y 40-70% en choque séptico.

Síndrome Coronario Agudo sin Elevación del ST

Tarjeta 1 -- FRENTE: ¿Qué distingue a la angina inestable del infarto sin elevación del ST?

REVERSO: Angina inestable: dolor torácico nuevo, progresivo o en reposo sin elevación de troponina o CK-MB (sin necrosis); el IAMSEST añade necrosis por bloqueo incompleto del flujo coronario.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Variables de la escala TIMI en SCA-SEST y definición de riesgo alto.

REVERSO: 7 variables (1 punto cada una): edad ≥ 65 , ≥ 3 factores de riesgo, arteriopatía coronaria conocida, ≥ 2 episodios de angina en 24 h, AAS en los últimos 7 días, desviación del ST ≥ 0.5 mV y troponina o CK-MB elevadas; 5-7 puntos = riesgo alto (mortalidad a un año 21%).

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Cuándo se determinan los biomarcadores en el SCA-SEST?

REVERSO: Antes de 60 minutos del ingreso y, si son negativos, repetir a las 6-12 h; la troponina es el mejor marcador pronóstico a 30 días y la CK-MB detecta mejor el reinfarto.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Terapia farmacológica inicial en todo paciente con SCA-SEST.

REVERSO: Antiánginosos (nitroglicerina, bloqueadores β) + AAS y clopidogrel + atorvastatina, salvo contraindicación; en riesgo bajo añadir heparina sin intensificar más (mayor sangrado sin beneficio).

Tarjeta 5 -- FRENTE: Criterios para elegir ICP frente a cirugía de revascularización en SCA-SEST.

REVERSO: ICP: enfermedad de 1-2 vasos con lesión culpable, SINTAX <13 o paciente sin diabetes; cirugía: SINTAX ≥ 13 o diabetes. Diferencial: la bivalirudina puede preferirse para ICP, pero no en el manejo inicial.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Conducta ante un ECG normal en sospecha de SCA-SEST.

REVERSO: Repetir el ECG a las 6-8 horas o antes del egreso y repetir biomarcadores; usar derivaciones V3R/V4R y V7-V9 si se sospecha isquemia derecha o posterior.

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda

Tarjeta 1 -- FRENTE: Criterios diagnósticos de Berlín del SDRA.

REVERSO: Dentro de 1 semana del insulto clínico, infiltrados bilaterales en radiografía o TAC, edema no cardiogénico (PCWP <15 mmHg o sin datos de insuficiencia cardíaca) e hipoxemia con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Gravedad del SDRA según la definición de Berlín.

REVERSO: Leve: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 201-300 mmHg; moderado: 101-200; grave: ≤ 100 . Diferencial: $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ de 200-300 mmHg define daño pulmonar agudo.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Causa más frecuente de SDRA.

REVERSO: Sepsis (causa indirecta); causas directas: neumonía, aspiración gástrica, inhalación de gases tóxicos y contusión pulmonar.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Parámetros de la ventilación mecánica protectora en SDRA.

REVERSO: Volumen corriente 6 mL/kg de peso ideal, presión meseta <30 cmH₂O y PEEP ajustada; posición prona en casos graves con $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 <150$.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Hallazgos que distinguen el SDRA del edema pulmonar cardiogénico.

REVERSO: SDRA: infiltrados periféricos, silueta cardíaca normal y PCWP <15 mmHg; cardiogénico: infiltrados centrales, cardiomegalia y PCWP >18 mmHg. Diferencial: el SDRA no mejora con diuréticos ni vasodilatadores.

Síndrome de Klinefelter

Tarjeta 1 -- FRENTE: Cariotipo más frecuente del síndrome de Klinefelter y su incidencia.

REVERSO: 47,XXY (variantes mosaico 48,XXXY y 49,XXXXY); incidencia de 1/500 neonatos varones; es hipogonadismo masculino por cromosoma sexual extra.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Dato de laboratorio característico en los leucocitos circulantes del paciente con Klinefelter.

REVERSO: Corpúsculo de Barr positivo (inactivación del cromosoma X extra); la confirmación se hace con cariotipo 47,XXY.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Perfil hormonal del síndrome de Klinefelter.

REVERSO: FSH elevada con testosterona reducida, por el cromosoma X adicional.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Varón joven con esterilidad, ginecomastia y talla alta: ¿qué síndrome sospechar y qué riesgo neoplásico tiene?

REVERSO: Síndrome de Klinefelter: atrofia testicular, azoospermia (esterilidad) y mayor riesgo de cáncer mamario; punto de examen: ginecomastia + masa mamaria en varón.

Talasemia

Tarjeta 1 -- FRENTE: Hallazgos de la talasemia β mayor (anemia de Cooley).

REVERSO: Anemia severa con alteraciones morfológicas en las primeras 6 semanas de vida, esplenomegalia a las 8 semanas, reticulocitos 5-15%, HbA2 y hemoglobina fetal aumentadas y sobrecarga de hierro; sin transfusión, Hb <3-5 g/dl.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Hallazgos electroforéticos y de frotis de la talasemia β menor.

REVERSO: HbA2 aumentada (3.5-8%), microcitosis, hipocromía, células en diana y puntilleo basófilo; es asintomática. Diferencial: no suplementar hierro salvo ferropenia documentada bioquímicamente.

Tarjeta 3 -- FRENTE: ¿Qué tetrámero de globina se acumula en la talasemia α y qué cromosoma se deleciona en la β ?

REVERSO: En la talasemia α se forman tetrámeros de globina β (hemoglobina H); en la β predomina la delección génica en el cromosoma 11 (exceso de cadenas α).

Tarjeta 4 -- FRENTE: Forma de talasemia α que cursa con hidropesía fetal.

REVERSO: Talasemia α mayor (delección de los 4 genes de globina α); la enfermedad de hemoglobina H presenta hemoglobina Bart al nacimiento en 20-40% de los casos.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Terapia transfusional en talasemias dependientes de transfusiones.

REVERSO: Iniciar con Hb <7 g/dl, meta >9.3 g/dl, con 15 ml/kg cada 3-5 semanas; quelación con deferoxamina; esplenectomía si requieren >200-250 ml/kg/año, diferida a los 4-6 años y precedida de vacunación antineumocócica.

Tarjeta 6 -- FRENTE: Patrón del hemograma característico de los síndromes talasémicos y prueba de confirmación.

REVERSO: Anemia microcítica hipocrómica con hematopoyesis inefectiva y hemolisis; el diagnóstico es obvio con electroforesis de hemoglobina. Diferencial: descartar ferropenia con ferritina, transferrina y TIBC antes de suplementar hierro.

Tirotoxicosis (Hipertiroidismo)

Tarjeta 1 -- FRENTE: Causa más frecuente de hipertiroidismo y su mecanismo.

REVERSO: Enfermedad de Graves (60-70%): anticuerpos contra el receptor de TSH con efecto agonista y bocio difuso; los anticuerpos anti-receptor tienen sensibilidad de 90-99%.

Tarjeta 2 -- FRENTE: Perfil hormonal del hipertiroidismo primario.

REVERSO: TSH disminuida con T4 elevada; si la T4 es normal, medir T3 (5-10% cursa con T3 elevada y T4 normal). Diferencial: la tirotoxicosis gestacional no tiene anticuerpos ni oftalmopatía.

Tarjeta 3 -- FRENTE: Cuadro clínico de la tormenta tiroidea y sus detonantes.

REVERSO: Hipertermia, delirium, taquiarritmias e insuficiencia cardíaca de gasto elevado; detonantes: estrés fisiológico, trauma, cirugía, enfermedad aguda o carga de yodo.

Tarjeta 4 -- FRENTE: Situaciones en las que se prefiere propiltiouracilo sobre metimazol.

REVERSO: Gestación en el primer trimestre, tormenta tiroidea, fracaso o efectos adversos con metimazol; además inhibe la conversión periférica de T4 a T3.

Tarjeta 5 -- FRENTE: Situaciones en las que se prefiere el yodo radiactivo.

REVERSO: Edad >50 años, adenoma tóxico y bocio tóxico multinodular (menor efectividad de las tionamidas y mayor frecuencia de adenomas).

Tarjeta 6 -- FRENTE: Efecto adverso de los antitiroideos que obliga a suspenderlos de inmediato.

REVERSO: Agranulocitosis (disminución de granulocitos obliga a discontinuación inmediata). Diferencial: la amiodarona produce tirotoxicosis tipo I (Jod-Basedow, con antitiroideos) y tipo II (tiroiditis destructiva, con corticoides).